NEUROLOGIA

Síndromes demenciais | Resumo e PTS

Resumo de tutoria e plano terapêutico singular

NESTE CADERNO

Conteúdo de estudo, quadros, figuras e referências dos materiais fornecidos.

11 páginas de conteúdo • Texto pesquisável • Navegação por marcadores

Edição visual padronizada. Conteúdo clínico mantido a partir dos arquivos de origem; esta edição não constitui revisão ou atualização das condutas.

RESUMO PARA DISCUSSÃO · TUTORIA

Síndromes Demenciais

As quatro principais causas, uma a uma: fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico e tratamento

1. A síndrome, antes da causa

Demência — hoje **transtorno neurocognitivo maior** — é declínio cognitivo ou comportamental **adquirido** e persistente, em relação a um nível prévio, que **compromete a independência** nas atividades de vida diária e não é explicado por delirium nem por transtorno psiquiátrico maior. O diagnóstico **não exige déficit de memória**: o DSM-5 abandonou essa exigência para acomodar as demências que começam pelo comportamento, pela linguagem ou pela visão. Os **seis domínios** avaliados são atenção complexa, função executiva, aprendizagem e memória, linguagem, perceptomotor e cognição social.

A fronteira que separa **comprometimento cognitivo leve** de demência é **funcional**, e não a nota do teste. No CCL há declínio objetivo **modesto** com **independência mantida** — o paciente demora mais, usa listas, confere duas vezes, mas ainda faz. Na demência, o declínio é **substancial** e alguém passou a administrar o dinheiro, os remédios ou o transporte. Os critérios C e D são comuns aos dois: não ocorre apenas no contexto de delirium e não é melhor explicado por outro transtorno mental. E vale o alerta conceitual: **CCL e demência são estágios; Alzheimer é etiologia** — existe "CCL devido à doença de Alzheimer".

2. A avaliação que vale para todas

O diagnóstico é **clínico**, e a **anamnese com informante** tem mais acurácia que qualquer teste. O **MEEM** só se interpreta com a escolaridade — cortes brasileiros de **20** para analfabetos, **25** para 1 a 4 anos, **26,5** para 5 a 8, **28** para 9 a 11 e **29** acima de 11 anos. O **Pfeffer** documenta a perda funcional e o **CDR** estadia (0,5 CCL · 1 leve · 2 moderada · 3 grave).

O **painel de exclusão** é o mesmo para qualquer suspeita: hemograma, glicemia, ureia e creatinina, sódio, potássio, cálcio, transaminases, **TSH**, **vitamina B12**, ácido fólico, **VDRL** e **anti-HIV**. A **neuroimagem** estrutural (TC ou, preferencialmente, RM) é obrigatória ao menos uma vez — exclui hematoma subdural crônico, tumor, hidrocefalia de pressão normal e doença cerebrovascular, além de mostrar o padrão de atrofia. A **punção lombar** fica reservada a casos atípicos: início precoce, curso rapidamente progressivo, suspeita de infecção ou neoplasia, sorologia reativa para sífilis, imunossupressão.

Para separar as causas, raciocine em **três eixos**: qual domínio começou, como o quadro evoluiu no tempo, e o que existe além da cognição no exame neurológico.

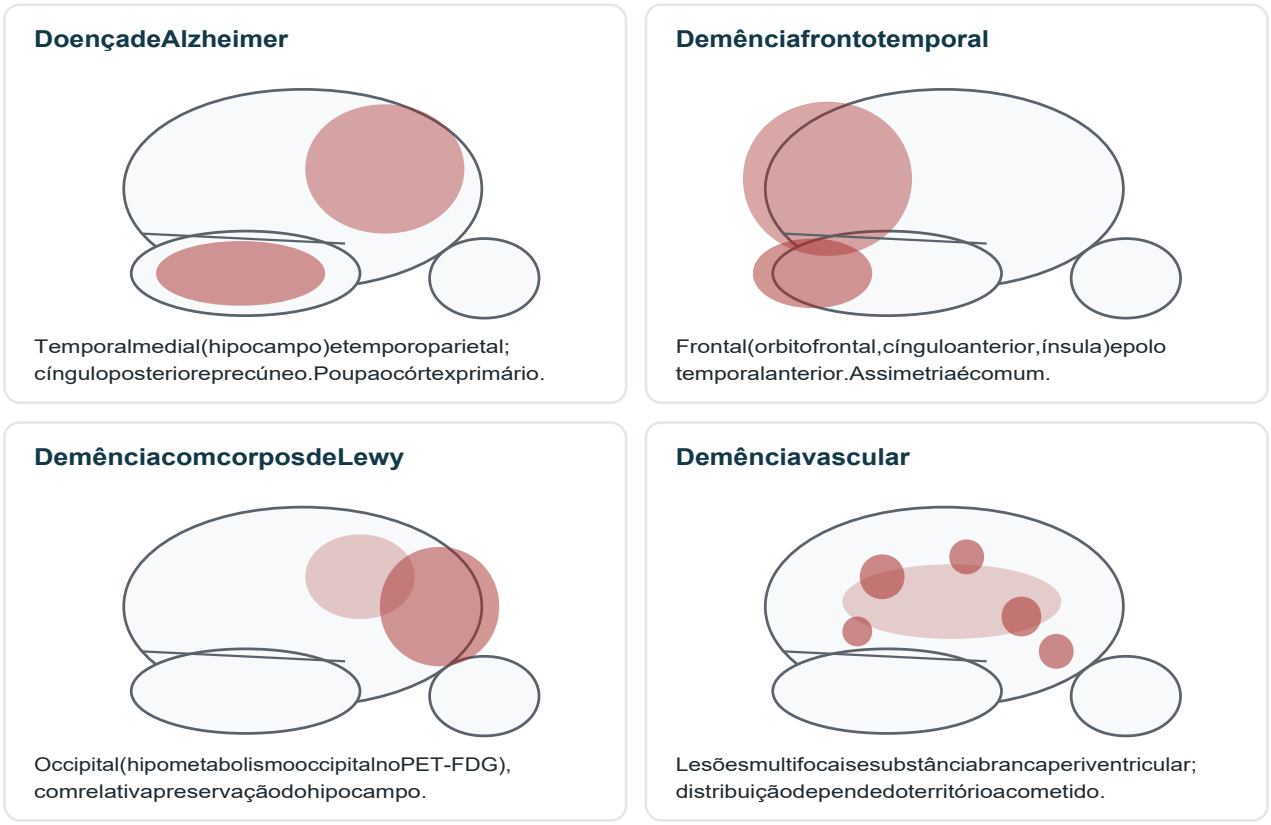


Figura 1 — Assinaturas topográficas das quatro principais demências. Esquemas laterais simplificados (polo frontal à esquerda, occipital à direita). A topografia da degeneração explica o perfil cognitivo inicial: hipocampo e temporoparietal produzem amnésia; frontal produz mudança de comportamento; occipital produz alucinação visual; substância branca produz lentificação e disfunção executiva.

3. Doença de Alzheimer

Responde por **50% a 70%** de todas as demências. A forma amnéstica corresponde a cerca de 85% dos casos.

FISIOPATOLOGIA

A proteína precursora amiloide é clivada pela via amiloidogênica — **β-secretase seguida de γ-secretase** — e gera o **Aβ42**, que se agrega em **oligômeros solúveis**, a espécie mais neurotóxica e responsável pela disfunção sináptica precoce, e depois em fibrilas e **placas senis** no espaço extracelular. Em paralelo, a proteína **tau** hiperfosforilada solta-se dos microtúbulos e forma **emaranhados neurofibrilares** dentro do neurônio. A lesão se propaga de forma estereotipada, nos estágios de Braak: **córtex entorrinal → hipocampo → neocórtex associativo**. Somam-se neuroinflamação, com micróglia e astrócitos inicialmente protetores e depois lesivos, e excitotoxicidade glutamatérgica pelo receptor NMDA. O resultado é perda sináptica e neuronal com **atrofia temporal medial**, e a degeneração do **núcleo basal de Meynert** produz o **déficit colinérgico** que fundamenta o tratamento sintomático. A patologia começa **15 a 20 anos** antes do primeiro sintoma, e os marcadores se alteram na ordem **amiloide → tau → neurodegeneração → cognição**.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Início **insidioso** e progressão **lenta e contínua**, sem degraus e sem platôs. O sintoma inicial é a **amnésia episódica anterógrada**: esquece o recente e preserva o remoto, repete a mesma pergunta, esquece compromissos e onde guardou objetos. Um detalhe cobrado em prova: a memória não melhora com pistas nem com reconhecimento, porque a falha é de **codificação** — o material nunca foi armazenado. No perfil subcortical (vascular, Parkinson) ocorre o oposto: a pista resgata a informação.

Seguem-se **desorientação temporal antes da espacial**, **anomia** com discurso empobrecido e circunlóquios, disfunção executiva com perda da capacidade de administrar finanças e medicações, e **anosognosia** — quem se queixa é a família, e o paciente costuma minimizar ou atribuir à idade. É frequente o *sinal do acompanhante*: o paciente vira-se para o familiar antes de responder.

Os **sintomas neuropsiquiátricos** ocorrem em todas as fases e pioram com a progressão — cerca de 90% dos pacientes apresentam ao menos um. Os mais característicos são o **delírio de roubo** (esconde objetos, não lembra, acusa a família), **alucinações visuais**, **identificação errônea** de familiares, apatia, irritabilidade, ansiedade, depressão, alteração do apetite e **inversão do ciclo sono-vigília** com agitação vespertina — a síndrome do entardecer.

A evolução por estágio, medida pelo CDR:

- **CDR 1 — leve.** Amnésia anterógrada evidente, desorientação temporal, anomia, redução da iniciativa. Falha nas **atividades instrumentais**: dinheiro, medicação, transporte, telefone, cozinhar. Ainda se veste e se higieniza sozinho.
- **CDR 2 — moderada.** Surgem **afasia**, **apraxia** (não sabe usar utensílios, erra a sequência de vestir) e **agnosia**. Precisa de ajuda nas **atividades básicas** — banho e vestuário. É o pico dos sintomas comportamentais e da sobrecarga do cuidador. Perambulação e risco de se perder.
- **CDR 3 — grave.** Dependência total, desorientação pessoal, linguagem reduzida a poucas palavras e depois mutismo, incontinência urinária e fecal, **disfagia**, rigidez, postura em flexão e imobilidade. Sobrevida média entre 3 e 8 anos após o diagnóstico, variando com a idade de início; a causa mais frequente de óbito é a **pneumonia** por broncoaspiração.

Apresentações atípicas, que enganam: **atrofia cortical posterior**, com queixa visual — dificuldade para ler, julgar distância, encontrar objetos no campo visual — em paciente com exame oftalmológico normal; variante **logopênica** da afasia progressiva primária, com pausas para encontrar palavras e falha na repetição de frases; e **variante disexecutiva ou frontal**, que imita frontotemporal. Também é atípico o **início precoce**, antes dos 65 anos, mais associado a formas genéticas.

DIAGNÓSTICO

É **clínico**, e parte do diagnóstico sindrômico de demência para só então definir a etiologia. Os critérios de **demência na doença de Alzheimer provável** (NIA-AA, endossados pela ABN e adotados pelo PCDT) exigem, além da síndrome demencial: **(A)** início insidioso, de meses a anos; **(B)** história clara de perda cognitiva referida pelo informante; **(C)** déficit inicial mais proeminente **amnéstico** — prejuízo do aprendizado e da evocação — ou, nas formas atípicas, de linguagem, visuoespacial ou executivo; **(D)tomografia ou, preferencialmente, ressonância** realizada para excluir outras possibilidades, principalmente doença vascular.

O item **(E)** é o que mais se esquece: o diagnóstico **não se aplica** quando há doença cerebrovascular importante — AVC com relação temporal, infartos múltiplos ou extensos, lesão acentuada de substância branca —, **características centrais de demência com corpos de Lewy**, características proeminentes de frontotemporal ou de afasia progressiva primária, ou outra doença ativa e uso de medicamento com efeito substancial sobre a cognição.

Pelo **DSM-5-TR**, a especificação exige início insidioso e progressão gradual, e distingue **provável** de **possível**. No transtorno neurocognitivo **maior**, "provável" se sustenta com três achados clínicos — declínio em memória e aprendizagem mais outro domínio, progressão constante e gradual sem platôs, e ausência de etiologia mista — ou com evidência de mutação causadora. No transtorno neurocognitivo **leve**, "provável" exige **obrigatoriamente evidência genética**; sem ela, com os mesmos três achados, fica "possível". Essa assimetria é pegadinha clássica.

Exames. O painel de exclusão da seção 2 é obrigatório na prática. A neuroimagem mostra tipicamente **atrofia temporal medial** — hipocampo e córtex entorrinal — com relativa preservação do córtex primário; a atrofia também pode ser temporoparietal e do precúneo. **Biomarcadores** (Aβ42 e p-tau no líquor, PET amiloide, razão plasmática p-tau217/Aβ) confirmam a biologia, mas **não estão disponíveis no SUS**; a ABN recomenda que o diagnóstico clínico venha primeiro e se posiciona **contra** o uso em assintomáticos ou em declínio cognitivo subjetivo.

Diagnóstico diferencial imediato: delirium (curso agudo, flutuação do nível de consciência, causa aguda identificável), depressão (queixa espontânea e detalhada, informante tranquilo, respostas "não sei", início definido), causas reversíveis da seção 7, e as outras três demências desta lista.

TRATAMENTO

Nenhum fármaco disponível no SUS altera o curso da doença. O objetivo é **estabilizar** cognição, comportamento e funcionalidade com o mínimo de eventos adversos — e isso precisa ser dito à família na primeira consulta, sob pena de expectativa frustrada e abandono do tratamento.

Anticolinesterásicos. Não há diferença de eficácia demonstrada entre os três; a escolha é por tolerância, comodidade e via.

- **Donepezila** — comprimidos de 5 e 10 mg. Iniciar **5 mg/dia** em dose única; aumentar para **10 mg/dia após 4 a 6 semanas**. É o **único autorizado também na fase grave**. Vigiar bradicardia, síncope, náusea, anorexia, perda de peso, cãibras, insônia e sonhos vívidos.
- **Rivastigmina** — cápsulas de 1,5 a 6 mg, solução oral de 2 mg/mL e **adesivo transdérmico** de 9 mg (5 cm²) e 18 mg (10 cm²). Por via oral: 1,5 mg duas vezes ao dia, com incrementos a cada duas semanas até 6 mg duas vezes ao dia. Adesivo: **9 mg/dia por pelo menos 4 semanas** e, se bem tolerado, **18 mg/dia**, que é a dose efetiva — não se mantém o adesivo menor por intolerância ao maior. O adesivo reduz muito os efeitos digestivos; exige rodízio do sítio de aplicação.
- **Galantamina** — cápsulas de liberação prolongada de 8, 16 e 24 mg. Iniciar **8 mg/dia** por 4 semanas, manutenção de **16 mg/dia**, máximo de 24 mg/dia. Ajustar para no máximo 16 mg/dia em insuficiência hepática ou renal moderada; contraindicada nas formas graves dessas insuficiências.

Memantina — comprimidos de 10 mg. Iniciar **5 mg/dia** com incrementos semanais de 5 mg até **20 mg/dia** (10 mg duas vezes ao dia). Entra a partir da fase moderada, combinada ao anticolinesterásico. Reduzir para 10 mg/dia se a depuração de creatinina ficar abaixo de 50 mL/min. É bem tolerada; pode causar cefaleia, tontura, confusão e alucinações.

Regras que a prova cobra. Nunca associar **dois anticolinesterásicos** — soma efeitos adversos sem somar benefício. A **troca** entre eles se justifica por **intolerância**, não por falta de resposta. **Suspender** quando não houver melhora nem estabilização após no mínimo seis meses, quando o MEEM cair abaixo do piso da faixa de escolaridade, na progressão para CDR 3 em uso de galantamina ou rivastigmina, ou por intolerância. **Reavaliar** com MEEM e CDR em **3 a 4 meses** e, depois, a cada **6 meses**, monitorando peso, frequência cardíaca e tolerância digestiva. São **critérios de exclusão**: incapacidade de adesão, bradicardia sintomática, bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro grau, doença do nó sinusal, arritmia ou insuficiência cardíaca graves, e asma ou doença pulmonar obstrutiva grave ou descompensada.

Fármacos a evitar: anticolinérgicos (amitriptilina, nortriptilina, oxibutinina, prometazina, hidroxizina, difenidramina), que antagonizam diretamente o tratamento; benzodiazepínicos; antipsicóticos de rotina; e sedativos em geral.

Anticorpos antiamiloides. **Lecanemabe** e **donanemabe** reduzem a carga de placas e produzem lentificação modesta do declínio, indicados apenas em **CCL ou demência leve** com **amiloide confirmado por biomarcador** e restritos a não portadores ou heterozigotos do alelo APOE ε4. O evento adverso que define o manejo é a **ARIA** — **ARIA-E**, edema vasogênico, e **ARIA-H**, micro-hemorragias e siderose —, mais frequente em homozigotos ε4, exigindo genotipagem e ressonâncias seriadas. Contraindicados na angiopatia amiloide e sob anticoagulação contínua. **Não incorporados ao SUS.**

4. Demência vascular

Segunda causa isolada e a de **maior potencial de prevenção**. A forma **mista**, com Alzheimer associado, é provavelmente a apresentação mais comum no idoso e é subestimada em vida.

FISIOPATOLOGIA

O fator de risco — hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, fibrilação atrial — lesa o vaso cerebral, e daí decorrem três mecanismos. **AVC estratégico** em território crítico (tálamo, giro angular, núcleo caudado, hipocampo) produz demência a partir de uma única lesão. **Múltiplos infartos** corticais ou lacunares somam déficits em degraus. A **doença de pequenos vasos**, por lipo-hialinose arteriolar, gera lacunas e lesão difusa da substância branca periventricular — a leucoaraiose. O denominador comum é a **desconexão frontossubcortical**: interrompem-se as fibras que ligam o lobo frontal ao restante do cérebro, o que explica ao mesmo tempo o perfil executivo e a alteração da marcha. Formas específicas: **angiopatia amiloide cerebral**, com hemorragias lobares e micro-hemorragias corticais, e **CADASIL**, hereditário por mutação no *NOTCH3*, em adulto jovem com enxaqueca com aura e AVCs de repetição.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

O padrão temporal é o principal diferencial: início **súbito** ou evolução **em degraus**, com pioras abruptas seguidas de estabilização ou até melhora parcial — diferente da curva contínua do Alzheimer. Na doença de pequenos vasos, porém, a evolução pode ser insidiosa e imitar o Alzheimer, e é aí que o diagnóstico erra.

O perfil cognitivo é **subcortical e frontal**: **lentificação do processamento**, déficit de atenção, e disfunção executiva — dificuldade de planejar, alternar tarefas, iniciar e inibir. A memória está relativamente mais preservada e, quando falha, **melhora com pistas**, porque o problema é de evocação e não de armazenamento.

Fora da cognição, o exame costuma ser anormal desde cedo — o que raramente acontece no Alzheimer inicial: **alteração precoce da marcha**, tipicamente de base alargada, com passos curtos e quedas; **sinais focais** como hemiparesia, hemi-hipoestesia, disartria e alterações de campo visual; liberação piramidal, com hiper-reflexia e sinal de Babinski; sinais pseudobulbares, com labilidade emocional, riso e choro imotivados e disfagia; e incontinência urinária precoce. A **depressão vascular**, com apatia proeminente, é comum e frequentemente confundida com o quadro cognitivo.

DIAGNÓSTICO

Exige três elementos simultâneos: **síndrome demencial**, **evidência de doença cerebrovascular na neuroimagem** e **relação plausível** entre as duas — temporal (o declínio começou ou piorou em até três meses após o evento) ou topográfica (a lesão explica o déficit encontrado). Achar leucoaraiose isolada em idoso não fecha o diagnóstico: é achado frequente e inespecífico.

O **escore de Hachinski** ajuda a separar do Alzheimer, pontuando início abrupto, deterioração em degraus, curso flutuante, confusão noturna, preservação relativa da personalidade, depressão, queixas somáticas, labilidade emocional, hipertensão, antecedente de AVC, aterosclerose associada, sintomas neurológicos focais e sinais neurológicos focais. Pontuações altas favorecem vascular; intermediárias sugerem forma mista.

Na **investigação**, além do painel de exclusão: perfil lipídico, glicemia e hemoglobina glicada, eletrocardiograma e, conforme o caso, ecocardiograma, Holter para detectar fibrilação atrial paroxística e Doppler de carótidas. A ressonância é superior à tomografia para caracterizar lacunas, extensão da substância branca e micro-hemorragias.

TRATAMENTO

Não há fármaco específico aprovado para a cognição. O tratamento é o **controle agressivo dos fatores de risco** e a **prevenção secundária de AVC**, e é aqui que se muda de fato o desfecho: controle pressórico, controle glicêmico, estatina, cessação do tabagismo, tratamento da apneia do sono e atividade física. Em doença aterotrombótica, **antiagregação**; em fibrilação atrial, **anticoagulação**, ponderando o risco de queda e de sangramento. Acrescentam-se reabilitação motora e cognitiva, fonoaudiologia na disfagia e manejo da depressão vascular, geralmente com ISRS.

Anticolinesterásicos têm benefício apenas marginal na forma puramente vascular e se justificam sobretudo quando há **componente misto** com Alzheimer — situação clínica frequente. Em pacientes com hemorragias lobares e suspeita de **angiopatia amiloide**, evitar anticoagulação sempre que possível.

5. Demência com corpos de Lewy

Terceira causa e a mais subdiagnosticada — e a única em que um erro de prescrição comum pode ser catastrófico.

FISIOPATOLOGIA

Depósitos intraneuronais de **alfa-sinucleína** — os corpos de Lewy — distribuídos em vários níveis, e é a distribuição que explica cada sintoma. No **córtex**, sobretudo occipital e frontal, produzem flutuação e alucinação visual. Na **substância negra**, produzem parkinsonismo. No **tronco encefálico**, o transtorno comportamental do sono REM. No **sistema autonômico**, a disautonomia. O **déficit colinérgico** é ainda mais intenso que no Alzheimer — por isso a boa resposta aos anticolinesterásicos — e a **hipersensibilidade dos receptores dopaminérgicos** explica a reação catastrófica aos antipsicóticos. É a mesma patologia da doença de Parkinson, com distribuição diferente.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

São **quatro características centrais**:

- **Flutuação cognitiva** — variação espontânea da atenção e do estado de alerta ao longo do mesmo dia, com episódios de olhar fixo, sonolência diurna excessiva e discurso desorganizado que depois melhora. É o achado que mais se confunde com delirium.
- **Alucinações visuais** recorrentes e **bem formadas** — tipicamente pessoas, crianças ou animais, muitas vezes vívidas e sem crítica preservada. Podem preceder o declínio cognitivo. Alucinações de presença e de passagem são comuns.
- **Parkinsonismo** — rigidez e bradicinesia predominantes, geralmente **simétrico**, com tremor de repouso menos proeminente que na doença de Parkinson, instabilidade postural e quedas precoces.
- **Transtorno comportamental do sono REM** — o paciente **representa o que sonha**, fala, grita, chuta, podendo ferir-se ou ferir o parceiro. Costuma preceder o quadro cognitivo em **anos ou décadas** e é o sintoma mais específico do grupo.

Achados de apoio: **hipersensibilidade neuroléptica** grave, **disautonomia** (hipotensão ortostática, síncope, constipação, incontinência), quedas repetidas, hiposmia, depressão, ansiedade, apatia, delírios sistematizados e síndrome de Capgras — a convicção de que um familiar foi substituído por um impostor. O perfil cognitivo é visuoespacial e executivo, com desempenho ruim no teste do relógio e na cópia de figuras, enquanto a **memória pode estar relativamente preservada no início**.

> **REGRA DE 1 ANO**
> Demência que surge **antes ou até um ano** do parkinsonismo é **demência com corpos de Lewy**. Depois de um ano de doença de Parkinson estabelecida, é **demência da doença de Parkinson**. A patologia é a mesma; a regra é convenção clínica — e cai em prova.

DIAGNÓSTICO

Clínico, pelos critérios de **McKeith**. Sobre a síndrome demencial, o diagnóstico é **provável** quando há duas características centrais, ou **uma característica central mais um biomarcador indicativo**; é **possível** com apenas uma característica central, ou com um biomarcador indicativo isolado. Os **biomarcadores indicativos** são a redução da captação dopaminérgica nos núcleos da base no **DAT-SPECT**, a captação reduzida na cintilografia miocárdica com **MIBG** e a **polissonografia** demonstrando sono REM sem atonia. Nenhum deles é rotineiramente disponível no SUS, de modo que o diagnóstico na prática depende de **perguntar ativamente** por parkinsonismo, quedas, síncope, alucinações e comportamento anormal durante o sono.

Na neuroimagem estrutural, o achado que ajuda é **o que não se vê**: o **hipocampo é relativamente poupado**, ao contrário do Alzheimer. Em imagem funcional, o característico é o **hipometabolismo occipital**, eventualmente com preservação do cíngulo posterior. Diferenciais principais: doença de Alzheimer com sintomas psicóticos, delirium, demência da doença de Parkinson (a regra de 1 ano) e paralisia supranuclear progressiva.

TRATAMENTO

Rivastigmina é a opção com melhor evidência, com resposta frequentemente boa sobre alucinações, flutuação e apatia — a resposta costuma ser melhor que no Alzheimer, justamente pelo déficit colinérgico mais intenso. Donepezila é alternativa. **Memantina** pode ser tentada nas fases mais avançadas.

Nunca antipsicótico típico, especialmente haloperidol: a hipersensibilidade neuroléptica pode causar rigidez grave, piora cognitiva abrupta, disautonomia e **síndrome neuroléptica maligna**, com risco de morte. Se um antipsicótico for imprescindível por risco à segurança, usar **quetiapina em dose baixa**, pelo menor tempo possível e com retirada programada.

Para o **parkinsonismo**, levodopa na menor dose eficaz, cientes de que pode piorar alucinações e confusão; agonistas dopaminérgicos e anticolinérgicos devem ser evitados. Para o **transtorno do sono REM**, **melatonina** em dose alta é a primeira escolha, com clonazepam em dose baixa como alternativa, além de medidas de segurança no quarto. Para a **hipotensão ortostática**, hidratação, sal, meias compressivas, elevação da cabeceira e, se necessário, fludrocortisona ou midodrina. Reabilitação motora e prevenção de quedas são parte do tratamento, não acessórios.

6. Demência frontotemporal

Principal causa de demência **antes dos 65 anos**, com pico entre 45 e 65 anos e forte carga familiar.

FISIOPATOLOGIA

Degeneração focal do **lobo frontal** e do **lobo temporal anterior**, com acúmulo de **tau** ou de **TDP-43**. A degeneração começa nas regiões **orbitofrontal, cíngulo anterior e ínsula** — circuitos do comportamento, da motivação e da cognição social. Como esses circuitos são atingidos antes do hipocampo, **a pessoa muda antes de esquecer**. Quando a degeneração predomina à esquerda, atinge as redes da linguagem e produz afasia. Cerca de 30% a 40% dos casos têm história familiar, com mutações conhecidas em *MAPT*, *GRN* e *C9orf72* — esta última também ligada à esclerose lateral amiotrófica.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Na **variante comportamental**, a mais frequente, o quadro é de mudança da personalidade com memória relativamente preservada:

- **Desinibição** — comentários socialmente inapropriados, familiaridade excessiva com estranhos, impulsividade, gastos e comportamento sexual inadequado.
- **Apatia** e perda de iniciativa, facilmente confundidas com depressão — mas sem tristeza correspondente.
- **Perda de empatia** — indiferença ao sofrimento alheio, frieza afetiva, perda do interesse por pessoas próximas. Costuma ser a queixa que mais fere a família.
- **Comportamentos perseverativos, estereotipados ou compulsivos** — rituais, colecionismo, repetição de frases, percursos fixos.
- **Hiperoralidade** e mudança alimentar — preferência marcante por **doces**, comer em excesso, ingerir itens não alimentares, aumento do consumo de álcool ou tabaco.
- Perfil neuropsicológico **disexecutivo**, com relativa preservação da memória episódica e das habilidades visuoespaciais.

São comuns a **perda de crítica** e a anosognosia completa, e o erro inicial de diagnosticar transtorno bipolar, depressão ou transtorno de personalidade — muitos pacientes passam meses ou anos em acompanhamento psiquiátrico antes do diagnóstico correto.

Nas **afasias progressivas primárias**, o quadro é de linguagem por pelo menos dois anos antes de outros domínios: a variante **não fluente / agramática** cursa com fala laboriosa, agramatismo e apraxia de fala, com compreensão de palavras isoladas preservada; a variante **semântica** cursa com fala fluente porém vazia, **anomia grave** e perda do significado das palavras e dos objetos, com repetição preservada. A variante **logopênica**, com pausas para encontrar palavras e falha na repetição de frases, costuma corresponder a **Alzheimer atípico**, e não a frontotemporal.

Pode haver associação com **doença do neurônio motor** — fasciculações, fraqueza, disartria, disfagia —, o que reduz muito a sobrevida.

DIAGNÓSTICO

Clínico, pelos critérios de **Rascovsky** para a variante comportamental: diagnóstico **possível** com pelo menos **três** entre desinibição, apatia, perda de empatia, comportamento perseverativo ou compulsivo, hiperoralidade e perfil disexecutivo com preservação relativa de memória e habilidades visuoespaciais; **provável** quando há, além disso, declínio funcional significativo e **neuroimagem compatível**; e **definitivo** com confirmação histopatológica ou mutação conhecida.

A neuroimagem mostra **atrofia frontal e temporal anterior**, tipicamente **assimétrica**, e o hipometabolismo correspondente na imagem funcional. A avaliação neuropsicológica é particularmente útil aqui, ao documentar disfunção executiva desproporcional à memória. Diferenciais: transtornos psiquiátricos primários — sobretudo mania e depressão —, doença de Alzheimer com apresentação frontal, e demência vascular com lesão frontal.

TRATAMENTO

Não há tratamento específico nem modificador. O manejo é **comportamental e ambiental**: rotina estruturada, redução de estímulos que disparam a compulsão, controle de acesso a dinheiro, chaves e alimentos, e antecipação de riscos legais e financeiros decorrentes da desinibição. **ISRS** — sertralina, citalopram, fluoxetina — e a trazodona podem reduzir desinibição, compulsões e hiperoralidade. **Não usar anticolinesterásico**: não há be-

nefício e há relatos de piora comportamental. Memantina também não demonstrou benefício. Antipsicótico apenas em situações de risco, em dose baixa e por tempo curto, lembrando que esses pacientes têm maior sensibilidade extrapiramidal.

Fonoaudiologia é central nas afasias, para estratégias de comunicação e, adiante, para a disfagia. O **suporte ao cuidador** é especialmente pesado: o paciente é jovem, fisicamente ativo, muitas vezes ainda economicamente responsável pela família, e o comportamento — não o esquecimento — é o que desorganiza a casa. Discutir precocemente afastamento do trabalho, benefícios, aconselhamento genético quando houver história familiar e planejamento de cuidados.

7. As causas que não podem ser perdidas

Somam de 1% a 5% dos casos, mas justificam sozinhas todo o painel laboratorial e a neuroimagem.

Causa	O que sugere	Conduta
Hidrocefalia de pressão normal	Tríade: apraxia de **marcha magnética** + incontinência urinária + declínio cognitivo; ventriculomegalia desproporcional à atrofia	*Tap test*; derivação ventriculoperitoneal nos respondedores
Deficiência de vitamina B12	Parestesias, alteração proprioceptiva, anemia macrocítica	Reposição
Hipotireoidismo	Lentificação, apatia, intolerância ao frio	Levotiroxina
Neurossífilis	Alteração de personalidade, delírios, pupila de Argyll Robertson	VDRL sérico e liquórico; penicilina cristalina
Hematoma subdural crônico	Idoso, anticoagulante, trauma que pode ter passado despercebido	Neuroimagem; drenagem se sintomático
Alcoólica e Wernicke-Korsakoff	Confusão, oftalmoparesia e ataxia; depois amnésia com confabulação	**Tiamina antes da glicose**; abstinência
Medicamentosa	Anticolinérgicos, benzodiazepínicos, opioides, anticonvulsivantes sedativos	Retirar — é a reversível mais frequente na prática
Depressão	Queixa espontânea e detalhada, informante tranquilo, respostas "não sei"	Rastrear e tratar; parte evolui depois para demência

Tabela 1 — Causas potencialmente reversíveis.

Demência rapidamente progressiva, de semanas a poucos meses, não é neurodegenerativa até prova em contrário: Creutzfeldt-Jakob (mioclonias, ataxia, complexos periódicos no eletroencefalograma, proteína 14-3-3), encefalite autoimune (crises, sintomas psiquiátricos, anticorpos anti-NMDAR ou anti-LGI1 — **tratável**), neoplasia, infecção e causas metabólicas. Internar e ampliar a propedêutica.

8. Tratamento no SUS e o que vale para todas

O **PCDT da Doença de Alzheimer** (Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 27, de 27 de novembro de 2025) inclui adultos com diagnóstico de **DA provável**, combinando faixas de MEEM estratificadas por escolaridade ao CDR.

Estágio	CDR	MEEM exigido (>4 anos / ≤4 anos de estudo)	Esquema autorizado
Leve a moderada	1 ou 2	12 a 24 / 8 a 21	Anticolinesterásico em **monoterapia**
Moderada	2	12 a 19 / 8 a 15	**Memantina combinada** ao anticolinesterásico
Grave	3	5 a 11 / 3 a 7	Memantina isolada, **donepezila** isolada, ou as duas

Tabela 2 — Doses: donepezila 5 mg/dia → 10 mg após 4 a 6 semanas; rivastigmina adesivo 9 mg/dia → 18 mg após 4 semanas; galantamina 8 → 16 → 24 mg/dia; memantina 5 mg/dia com incrementos semanais até 20 mg/dia. Exclusão: bradicardia sintomática, bloqueio atrioventricular, doença do nó sinusal, arritmia ou insuficiência cardíaca graves, asma ou doença pulmonar obstrutiva grave.

VALE PARA AS QUATRO, EM QUALQUER ESTÁGIO

Suporte e educação do **cuidador** — a única intervenção com efeito consistente sobre o tempo até a institucionalização · **exercício físico** regular · estimulação cognitiva · rotina previsível e ambiente seguro · correção de **audição e visão** · revisão de fármacos que pioram a cognição · prevenção de quedas · **planejamento antecipado de cuidados**.

SINTOMAS COMPORTAMENTAIS E O QUE NÃO PRESCREVER

Três passos: **1)** procurar causa — infecção, dor, constipação, retenção urinária, fármaco novo; **2)** medida ambiental; **3)** fármaco só com risco à segurança ou sofrimento intenso, em dose baixa e com retirada programada. **Evitar**: anticolinérgicos (amitriptilina, oxibutinina, prometazina, hidroxizina, difenidramina), benzodiazepínicos, antipsicóticos de rotina — com advertência de aumento de mortalidade em idosos com demência — e contenção física.

9. Pontos para levar à discussão

- A fronteira entre CCL e demência é **funcional**; o MEEM **sem escolaridade** não se interpreta — e, no Brasil, a escolaridade define também a faixa autorizada pelo PCDT.
- Amnésia que **não melhora com pistas** aponta Alzheimer; a que melhora aponta perfil subcortical, como o vascular.
- Exame neurológico anormal **desde cedo** afasta Alzheimer inicial e sugere vascular, corpos de Lewy ou parkinsonismo atípico.
- Alucinação visual precoce e flutuação obrigam a perguntar por **parkinsonismo e sono REM** antes de prescrever qualquer antipsicótico.
- Comportamento que muda antes da memória, em paciente com menos de 65 anos, é **frontotemporal** até prova em contrário.
- Amiloide positivo em pessoa **assintomática** não é demência: pelos critérios biológicos da NIA-AA de 2024 já seria doença de Alzheimer; pelo IWG e pela prática clínica, é apenas risco.
- No Brasil, cerca de **8,5%** das pessoas com 60 anos ou mais vivem com demência e apenas cerca de **20%** dos casos estão formalmente diagnosticados. A *Lancet Commission* de 2024 lista **14 fatores modificáveis**, e a estimativa brasileira de fração atribuível chega a cerca de 60%.

Doses, faixas de MEEM e critérios de inclusão seguem o PCDT da Doença de Alzheimer (Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 27, de 27 de novembro de 2025) e devem ser confirmados em bula vigente e no texto original da portaria. Critérios diagnósticos conforme DSM-5-TR, NIA-AA e recomendações da Academia Brasileira de Neurologia.

PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR

Maria Rita — problemas, metas e ações

Síndrome demencial em investigação etiológica — acompanhamento na atenção básica

Maria Rita, idosa, baixa escolaridade. Trazida pela filha Shirley por esquecimentos há meses, em piora. Confunde as filhas, troca o dia pela noite, esqueceu o fogo aceso. Precisa de ajuda para vestir-se, cozinhar e tomar os medicamentos. Esconde objetos e acusa a família de roubo; disse ter visto um homem no quarto. Roupas trocadas, **desorientada no tempo** e parcialmente no espaço, atenção flutuante, memória recente prejudicada com remota preservada, anomia, funções executivas comprometidas, juízo crítico prejudicado, **insight ausente**. **MEEM 16/30** · **Pfeffer 20/30** · **Yesavage 3/15**. Avó com "pequenos AVCs". Painel laboratorial e TC de crânio solicitados.

1. Lista de problemas

#	Problema	Situação	Base
1	**Síndrome demencial** (transtorno neurocognitivo maior), estágio moderado	CONFIRMADO	Declínio adquirido, persistente, em múltiplos domínios, com perda da independência
2	**Dependência em atividades de vida diária**	CONFIRMADO	Pfeffer 20/30; ajuda para vestir-se, cozinhar e medicar-se
3	**Sintomas comportamentais** — delírio de roubo, alucinação visual, irritabilidade	CONFIRMADO	Relato da filha e exame do estado mental
4	**Inversão do ciclo sono-vigília**	CONFIRMADO	"Troca o dia pela noite"
5	**Risco domiciliar** — fogo aceso, medicação sem supervisão, perambulação, quedas	CONFIRMADO	Esqueceu de apagar o fogo; desorientação espacial parcial
6	**Sobrecarga da cuidadora** e inversão de papéis	CONFIRMADO	Shirley exausta e chorosa; "às vezes me sinto sozinha"
7	**Anosognosia com juízo crítico prejudicado**	CONFIRMADO	Insight ausente; repercute em direção, finanças e consentimento
8	**Etiologia da demência** — hipótese de doença de Alzheimer	A ESCLARECER	Quadro compatível, mas sem exclusão de causa secundária: sustenta "possível", não "provável"
9	**Causas reversíveis** — tireoide, B12, sífilis, HIV, metabólicas, estruturais	A ESCLARECER	Painel laboratorial e tomografia ainda não realizados
10	**Componente vascular**	A ESCLARECER	História familiar; tomografia pendente; fatores de risco não documentados
11	**Demência com corpos de Lewy**	A ESCLARECER	Atenção flutuante e alucinação visual; falta perguntar parkinsonismo, quedas, síncope e sono REM
12	**Delirium sobreposto**	A ESCLARECER	Sem sinais vitais nem rastreio de infecção, dor ou constipação; "atenção flutuante" é achado nuclear
13	**Causa medicamentosa ou por substância**	A ESCLARECER	Medicamentos em uso e consumo de álcool não colhidos
14	**Escolaridade em anos**	A ESCLARECER	Define o corte do MEEM e a faixa autorizada pelo PCDT
15	**Estadiamento formal pelo CDR**	A ESCLARECER	Clinicamente moderado, mas não registrado — o PCDT exige CDR na faixa prevista
16	**Audição e visão**	A ESCLARECER	Não avaliadas; déficit sensorial piora cognição e favorece alucinação
17	**Avaliação cardíaca antes do anticolinesterásico**	A ESCLARECER	Sem frequência cardíaca nem eletrocardiograma; bradicardia e bloqueio atrioventricular são critérios de exclusão do PCDT

2. Metas

Meta	Prazo	Como se verifica
Manter a paciente segura em casa	**Imediato**	Plano escrito para gás, medicação, identificação e supervisão
Completar o que faltou da avaliação	**Esta consulta**	CDR, escolaridade em anos, medicamentos em uso, exame neurológico e anamnese dirigida registrados
Excluir causa reversível e delirium	**4 semanas**	Painel laboratorial e tomografia vistos em consulta de retorno
Definir a etiologia	**8 semanas**	Diagnóstico etiológico registrado com justificativa
Iniciar o tratamento específico	**Esta consulta**	Donepezila iniciada, com orientação à família sobre efeito esperado e efeitos adversos
Formalizar o processo no Componente Especializado	**4 a 6 semanas**	Neuroimagem e laboratório vistos, MEEM e CDR registrados, formulário do PCDT preenchido
Controlar os sintomas comportamentais sem antipsicótico contínuo e restabelecer o sono	**3 meses**	Sem risco à segurança, sem prescrição prolongada, sono noturno consolidado
Reduzir a sobrecarga da cuidadora	**6 meses**	Zarit em queda; cuidado dividido; Shirley em grupo de apoio
Planejar o futuro enquanto ela ainda decide	**6 meses**	Preferências conversadas; questão financeira e legal encaminhada
Evitar internação e complicação evitável	**Contínuo**	Sem hospitalização por delirium, queda ou broncoaspiração

O QUE DOCUMENTAR PARA SUSTENTAR O DIAGNÓSTICO E O PROCESSO

DSM-5-TR: A cumprido — declínio substancial em múltiplos domínios; B cumprido pelo Pfeffer 20/30; C exige registrar sinais vitais e afastar causa aguda, já que "atenção flutuante" também é achado de delirium; D cumprido quanto à depressão (Yesavage 3/15), faltando anotar os medicamentos em uso.

Alzheimer provável (NIA-AA/ABN, critério de inclusão do PCDT): início insidioso e progressão gradual — sim; história pelo informante — sim; apresentação **amnéstica** — sim. Faltam dois itens formais: a **neuroimagem**, que o critério D exige, e a exclusão explícita do critério E — sobretudo **corpos de Lewy**, já que alucinação visual e flutuação cognitiva estão descritas, e **doença cerebrovascular**, que depende da tomografia. Registrar por escrito a ausência de parkinsonismo, quedas, síncope e comportamento anormal no sono resolve o primeiro; a imagem resolve o segundo.

Antes da primeira dose: conferir **frequência cardíaca** e antecedentes de asma, doença pulmonar obstrutiva e arritmia — bradicardia, bloqueio atrioventricular e doença pulmonar grave são critérios de exclusão do PCDT para os anticolinesterásicos.

5. Ações

CURTO PRAZO *desta consulta até 4 semanas*

Completar a avaliação, ainda nesta consulta

- Registrar **CDR** e a **escolaridade em anos**
- Sinais vitais, **frequência cardíaca** e **exame neurológico**: sinais focais, parkinsonismo, marcha
- Rastrear causa aguda: infecção urinária ou respiratória, dor, constipação, retenção
- Listar **medicamentos em uso** e consumo de álcool
- Perguntar por quedas, síncope, disautonomia e comportamento anormal no sono
- Aplicar a escala de **sobrecarga do cuidador** (Zarit)

Solicitações e prescrições

- Hemograma, glicemia, ureia, creatinina, sódio, potássio, cálcio, transaminases
- **TSH**, **vitamina B12**, sorologia para **sífilis** e **anti-HIV**
- **Tomografia de crânio sem contraste** — é critério formal de inclusão do PCDT, não apenas complementar
- **Eletrocardiograma** antes do anticolinesterásico
- **Iniciar donepezila 5 mg/dia**, em dose única, à noite
- Exames solicitados **em paralelo**, não antes: rever a conduta se o painel ou a imagem revelarem causa secundária
- Retirar da prescrição qualquer **anticolinérgico** ou **benzodiazepínico**

Orientações à família

- **Segurança:** gás fechado entre as refeições, medicamentos sob guarda de terceiro, identificação com nome e telefone junto ao corpo, portas de saída controladas
- Suspender **direção veicular** e o manejo autônomo do dinheiro
- Revisar calçado, iluminação noturna, tapetes e barras de apoio
- **Comunicação:** não corrigir, não confrontar, não argumentar com o delírio — validar e redirecionar
- No delírio de roubo, ajudar a procurar o objeto em vez de negar o furto
- **Sono:** luz natural pela manhã, evitar cochilos longos, sem cafeína à tarde
- Explicar que os sintomas são da doença, e não intencionais — inclusive a Raquel
- **Retorno imediato** se piora em dias, febre, queda com trauma na cabeça ou engasgo às refeições

Encaminhamentos

- **Geriatria ou neurologia** — confirmação e abertura do processo do PCDT
- **Terapia ocupacional** — adaptação das atividades e do ambiente
- **Serviço social / CRAS** — avaliação social e benefícios · **ABRAz** — grupo de apoio

MÉDIO PRAZO *1 a 6 meses*

Prescrições

- Tratar o que os exames revelarem: reposição de B12, levotiroxina, penicilina benzatina
- **Donepezila**: subir para **10 mg/dia após 4 a 6 semanas**, se bem tolerada
- Se houver intolerância digestiva: **rivastigmina adesivo 9 mg/dia**, subindo para 18 mg/dia após 4 semanas
- **Memantina** associada ao inibidor, conforme a faixa de MEEM autorizada pelo PCDT
- Antipsicótico só com risco à segurança ou sofrimento intenso: **quetiapina em dose baixa**, com retirada programada. **Nunca haloperidol** enquanto corpos de Lewy não estiver afastado
- Vacinas em dia; controle de pressão, glicemia e lipídios

Encaminhamentos e monitorização

- **Fisioterapia** — marcha, equilíbrio e prevenção de quedas
- **Fonoaudiologia** — linguagem
- **Oftalmologia e otorrinolaringologia** — corrigir déficit sensorial
- Visita domiciliar da equipe de saúde da família
- Exercício físico e estimulação cognitiva ajustada à escolaridade
- **MEEM e CDR em 3 a 4 meses**; peso, frequência cardíaca e tolerância digestiva a cada retorno
- Revisão da prescrição inteira a cada consulta

LONGO PRAZO *a partir de 6 meses*

- **Reavaliação semestral** com MEEM e CDR; ajustar o esquema conforme o estágio
- **Suspender** se não houver melhora nem estabilização em cerca de 6 meses, se o MEEM cair abaixo do piso da faixa ou se progredir para CDR 3 em uso da medicação. Falta de resposta indica suspender, **não trocar de inibidor**
- Antecipar a fase avançada: **disfagia**, imobilidade, infecções de repetição e broncoaspiração
- Acompanhamento nutricional e adequação da consistência da dieta
- **Planejamento antecipado de cuidados**: preferências, procuração e, se necessário, curatela
- Suporte continuado à cuidadora, com reavaliação periódica da sobrecarga
- Discutir **cuidados paliativos** quando a doença avançar, definindo até onde intervir

NÃO PRESCREVER

Anticolinérgicos (amitriptilina, oxibutinina, prometazina, hidroxizina, difenidramina) — pioram a cognição e antagonizam o tratamento. **Benzodiazepínicos** — quedas, fratura e delirium; não são a resposta para a inversão dia-noite. **Haloperidol** e demais antipsicóticos típicos. **Contenção física.** E **anticolinesterásico sem conferir frequência cardíaca e antecedente cardiopulmonar**.

Doses, faixas de MEEM e critérios de inclusão seguem o PCDT da Doença de Alzheimer (Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 27, de 27 de novembro de 2025) e devem ser confirmados em bula vigente e no texto original da portaria antes da aplicação clínica. O diagnóstico etiológico é o mais provável diante dos dados disponíveis e deve ser reconfirmado quando o painel laboratorial e a tomografia retornarem.